# Pack stage IFSI (constantes, échelles, transmissions, précautions)

Repères de l'adulte pour le stage : constantes, échelles, transmissions, hygiène et AES

Clairance

*Référentiel 2026 (arrêté du 20 février 2026, entrant.e.s à partir de septembre 2026) : notions mobilisées notamment dans l'UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » (S1, S2 dans le programme publié par l'UBE).*
*Repères de l'adulte. Les valeurs, seuils et conduites du protocole de votre service priment.*

## 1 Constantes de l'adulte

| Paramètre | Repère | Unité |
|---|---|---|
| Fréquence cardiaque (repos) | 60 à 100 | /min |
| Pression artérielle (consultation) | HTA si ≥ 140/90 persistante | mmHg |
| Pression artérielle (automesure) | HTA si ≥ 135/85 | mmHg |
| Pression artérielle basse | PAS < 90 ou PAD < 60, ou en chute | mmHg |
| Fréquence respiratoire (repos) | 12 à 18 | /min |
| $SpO_2$ (air ambiant) | ≥ 95 | % |
| Température | 36,5 à 37,3 | °C |

**NOTE CLINIQUE Valeur anormale : consigne de prudence**
Valeur très anormale ou patient.e qui va mal : **alerter immédiatement** selon le protocole, puis recontrôler. Valeur anormale isolée chez un.e patient.e stable : recontrôler (matériel, position, repos) et comparer aux valeurs précédentes avant de signaler. En cas de doute, alerter.

**PIÈGE**
Un chiffre « normal » ne rassure pas seul : la tendance (valeurs successives) et l'aspect du.de la patient.e comptent autant. Une cible prescrite pour ce.tte patient.e ($SpO_2$ notamment) passe avant le repère du tableau.

## 2 Échelles de la douleur

| Échelle | Cotation et seuil de l'indicateur HAS |
|---|---|
| EVA | Auto-évaluation. Réglette de 0 à 10 cm (0 à 100 mm). Prise en charge requise si ≥ 4/10 (≥ 40/100). |
| EN | Auto-évaluation. Note de 0 à 10 donnée par le.la patient.e. Même seuil que l'EVA. |
| EVS | Auto-évaluation (échelle verbale simple). De 0 (absente) à 4 (extrêmement intense) : absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense. Prise en charge requise si ≥ 2. |
| Algoplus | Hétéro-évaluation, personne âgée qui ne peut pas s'auto-évaluer. Score de 0 à 5. Prise en charge requise si ≥ 2. |

Sous ces seuils, la douleur reste évaluée, tracée et prise en compte ; la conduite est celle du protocole du service.

**PIÈGE**
Choisir **une** échelle et la garder pour suivre l'évolution : un score d'EVA et un score d'EN ne se comparent pas d'une prise à l'autre. Tracer l'échelle utilisée avec le score.

## 3 Score de Glasgow

| Item | Points | Meilleure réponse obtenue |
|---|---|---|
| **Yeux (Y)** | 4 | Ouverture spontanée |
| | 3 | À la demande ou au bruit |
| | 2 | À la douleur |
| | 1 | Aucune |
| **Verbal (V)** | 5 | Orientée |
| | 4 | Confuse |
| | 3 | Mots inappropriés |
| | 2 | Sons incompréhensibles |
| | 1 | Aucune |
| **Moteur (M)** | 6 | Obéit aux ordres |
| | 5 | Localise la douleur |
| | 4 | Évitement (retrait) |
| | 3 | Flexion stéréotypée (décortication) |
| | 2 | Extension stéréotypée (décérébration) |
| | 1 | Aucune |

Score = Y + V + M, de 3 à 15. Noter le détail des trois items, pas seulement le total. Réponse non testable (patient.e intubé.e, paupières œdématiées) : noter NT et la raison, ne pas coter 1.

**EXEMPLE Calcul du score**
Yeux à la demande (3), réponse confuse (4), localise la douleur (5) : 3 + 4 + 5 = 12, à noter Y3 V4 M5.

**NOTE CLINIQUE Baisse du score**
Toute baisse par rapport à la cotation précédente s'alerte immédiatement, selon le protocole du service.

## 4 Risque d'escarre : échelle de Braden

| Item | Cotation |
|---|---|
| Perception sensorielle | 1 à 4 |
| Humidité | 1 à 4 |
| Activité | 1 à 4 |
| Mobilité | 1 à 4 |
| Nutrition | 1 à 4 |
| Friction et cisaillement | 1 à 3 |

Score total de 6 à 23 : **plus le score est bas, plus le risque est élevé**. Le seuil qui déclenche les mesures de prévention est celui du protocole du service.

## 5 Transmissions

**Transmissions ciblées**

- **Cible** : ce qui pose problème ou change (symptôme, réaction, événement), en quelques mots.
- **D, données** : faits observés et mesurés, propos du.de la patient.e.
- **A, actions** : ce qui a été fait, et par qui.
- **R, résultats** : effet observé, réévalué à l'heure dite.

**SAED (adaptation française de SBAR, HAS)**

- **S, situation** : qui j'appelle, pour quel.le patient.e, motif de l'appel, constantes.
- **A, antécédents** : contexte, traitements, allergies, évolution récente.
- **E, évaluation** : ce que j'en pense, ce qui m'inquiète.
- **D, demande** : ce que j'attends, dans quel délai.

**NOTE CLINIQUE Traçabilité**
Écrire ce qui est fait, quand il est fait : date, heure, identification de l'auteur.rice. Chaque administration est tracée sur le même support que la prescription. Faits objectifs, sans jugement ; jamais d'acte tracé à l'avance.

## 6 Précautions standard

**Champ (SF2H)**
Pour tout soin, en tout lieu, pour tout.e patient.e, quel que soit son statut infectieux.

**Les 5 indications de l'hygiène des mains (OMS)**

1. Avant de toucher un.e patient.e.
2. Avant un geste aseptique.
3. Après un risque d'exposition à un liquide biologique.
4. Après avoir touché un.e patient.e.
5. Après avoir touché l'environnement du.de la patient.e.

| Mesure | Repère |
|---|---|
| Mains | Friction hydro-alcoolique : technique de référence, gants ou non. Mains visiblement souillées : lavage à l'eau et au savon. *C. difficile*, gale : lavage au savon **puis** friction (friction seule inefficace). |
| Gants | Si risque de contact avec du sang, un liquide biologique, une muqueuse ou une peau lésée ; pas de gants pour un contact avec une peau saine. |
| Masque, lunettes | Risque de projection : masque et lunettes, type de masque selon le protocole. Patient.e qui tousse : masque à usage médical, au minimum de type I (norme EN 14683). |
| Matériel | Matériel de sécurité et à usage unique ; conduite AES connue de tous. |

## 7 Précautions complémentaires

**Respiratoires (SF2H 2024)**
La SF2H a remplacé en 2024 la distinction Air / Gouttelettes par trois niveaux de précautions complémentaires respiratoires : simples, renforcées, maximales. Le niveau et le type de masque (soignant.e, patient.e) suivent le protocole de l'établissement et l'équipe d'hygiène.

| Type | Mesures (en plus des précautions standard) |
|---|---|
| Contact | Chambre seule ou regroupement, signalée. Tablier pour les soins directs. Hygiène des mains en sortant de la chambre. |

Rédaction assistée par IA ; contenu vérifié et validé par le vendeur. · Outil de révision. Il complète vos cours et ouvrages de référence, il ne les remplace pas. · Ne remplace ni les protocoles de votre service, ni la prescription médicale, ni l'avis d'un.e professionnel.le de santé.

**⚠ PIÈGE**
Les précautions sont prescrites et signalées : suivre la signalétique et le protocole du service, ne pas déduire le niveau du diagnostic supposé.

## 8 Accident d'exposition au sang (AES)

**Premiers soins, tout de suite (INRS)**

**Piqûre, coupure, peau lésée :** ne pas faire saigner ; nettoyer à l'eau et au savon, rincer ; désinfecter au moins 5 min (Dakin, ou eau de Javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5e ; à défaut polyvidone iodée en solution dermique ou alcool à 70°).
**Projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez) :** rincer abondamment au moins 5 min au sérum physiologique ou à l'eau.

**✚ NOTE CLINIQUE Délais**
**Sous 1 h :** avis médical, selon la procédure AES de l'établissement, pour évaluer le risque infectieux ; un traitement post-exposition, s'il est indiqué, débute idéalement dans les 4 h.
**Dans les 24 h :** informer sa hiérarchie (en stage : le service et l'IFSI), déclarer l'accident du travail, suivre les recommandations médicales, informer le.la médecin du travail.

**⚠ PIÈGE**
Ne pas attendre la fin du soin ou du poste pour consulter : le délai compte à partir de l'accident.

*Sources : HAS (HTA, douleur IQSS, SAED), MedlinePlus (FC, PA basse), Manuel MSD et CHUV (Glasgow), SF2H (précautions standard, contact, respiratoires 2024), CPias Hauts-de-France, OMS (hygiène des mains), INRS (AES), AP-HP (dossier de soins), HUG (Braden), arrêtés du diplôme d'État d'infirmier ; détail dans les références du produit.*